



Trastorno del Sueño-Vigilia

Otra noche despierto. Mi cuerpo agotado y mi mente organizando debates que nadie pidió.

Psicopatologías 1 de la niñez y adolescencia

Trastorno del Sueño – Vigilia

Profesora Aelen López

Licda. Yasari Garrido

2-5-26

Introducción

Los trastornos del sueño y vigilia son alteraciones en la calidad, cantidad o horario del descanso, provocando somnolencia diurna, insomnio y disfunción diaria siendo comunes el insomnio, apnea del sueño, narcolepsia en toda la población.

A continuación detallaremos cada uno de estos trastornos.

Causas y Factores de Riesgo

- ***Estilo de vida:*** Viajes, trabajos nocturnos, uso de pantallas y consumo de cafeína/alcohol.
- ***Afecciones Médicas:*** Depresión, ansiedad, Alzheimer, párkinson, insuficiencia cardíaca y dolor crónico.
- ***Medicamentos:*** Sustancias que afectan el sistema nervioso.

Clinic



Mayo

Principales Trastornos del Sueño – Vigilia

DSM-5TR se basa en 10 trastornos.

- 1. Trastorno de Insomnio.***
- 2. Trastorno de Hipersomnolencia, Narcolepsia.***
- 3. Trastorno del sueño relacionados con la respiración.***
- 4. T. Sueño-vigilia del ritmo circadiano.***
- 5. Trastorno del despertar del sueño con movimientos oculares no rápidos. (NREM).***



Principales Trastornos del Sueño y Vigilia

DSM-5TRse basa en 10 trastornos.

6. Trastornos de Pesadillas.

7. Trastornos del movimiento ocular rápido (REM).

8. Trastorno del comportamiento del sueño.

9. Síndrome de piernas inquietas.

10. Trastornos inducidos por sustancias/medicamentos.



Cuadro comparativo CIE-11 vs (Trastornos del Sueño-Vigilia.

<i>CIE-11</i>	<i>DSM-5-TR</i>
• <i>La CIE-11 busca utilidad clínica global y la OMS.</i> • <i>Clasificación clínica/epidemiológica internacional.</i> • <i>Estructura: Reorganizada para eliminar distinción orgánico/no orgánico.</i>	• <i>El DSM-5-TR se enfoca en la práctica psiquiátrica estadounidense.</i> • <i>Diagnóstico y estadístico para salud mental.</i>

Diferencias Clave entre CIE-11 y DSM-5TR(Trastornos del Sueño-Vigilia).

Enfoque de la CIE-11	Clasificación de Narcolepsia	DSM-5-TR
CIE-11 Se ha enfocado en simplificar el diagnóstico del insomnio, destacando que el "sueño no reparador" por sí solo, sin dificultades de inicio o mantenimiento, no es suficiente para el diagnóstico de trastorno de insomnio.	La CIE-11 y la ICSD-3 detallan la narcolepsia en tipos 1 y 2, mientras que el DSM-5-TR se enfoca en la deficiencia de hipocretina o cataplexia.	DSM-5-TR se enfoca en la deficiencia de hipocretina o cataplexia.
CIE-11 y DSM-5-TR Ambos manuales coinciden en que los trastornos del sueño-vigilia se definen por una	insatisfacción en la calidad, cantidad y tiempo de sueño, provocando malestar	clínicamente significativo en el funcionamiento diurno ,laboral, social, etc.

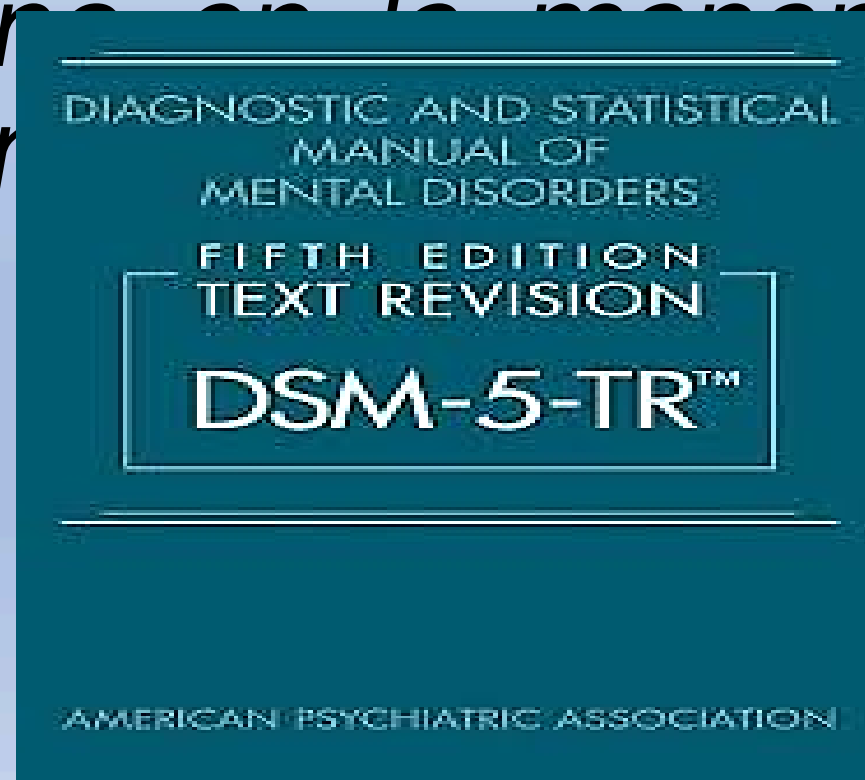
Trastorno de Insomnio DSM-5TR

Criterios de diagnóstico

A. Una queja predominante de insatisfacción con la cantidad o calidad del sueño

1. Dificultad para iniciar el sueño caracterizada por despertares.

2. Despertar temprano en la mañana con incapacidad para volver a dormir.



Trastorno de Insomnio DSM-5TR

Criterios de diagnóstico

B. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, ocupacional, educativo, académico, conductual u otras áreas importantes del funcionamiento.

C. La dificultad para dormir ocurre al menos 3 noches por semana.

D. La dificultad para dormir persiste durante al menos 3 meses.



Trastorno de Insomnio DSM-5TR

Criterios de diagnóstico

E. La dificultad para dormir ocurre a pesar de la oportunidad adecuada para dormir.

F. El insomnio no se explica mejor y no ocurre exclusivamente durante el curso de otro trastorno del sueño y la vigilia como narcolepsia, apnea y la vigilia, una parasomnia.



Trastorno de Insomnio DSM-5TR

Criterios de diagnóstico

- *G. El insomnio no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o de abuso, un medicamento.*
- *H. Los trastornos mentales y las condiciones médicas coexistentes no explican o explican adecuadamente la queja predominante.*



Funciones asociadas al Trastorno de Insomnio DSM-5TR

Con la excitación fisiológica y cognitiva y con factores condicionantes que interfieren con el sueño, una preocupación por el sueño y la angustia por la incapacidad para dormir puede conducir a un círculo vicioso: cuanto más se esfuerza el individuo por dormir, más frustración se acumula y más perjudica el sueño.



La Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño-Vigilia en su 3.^a edición ICSD-3

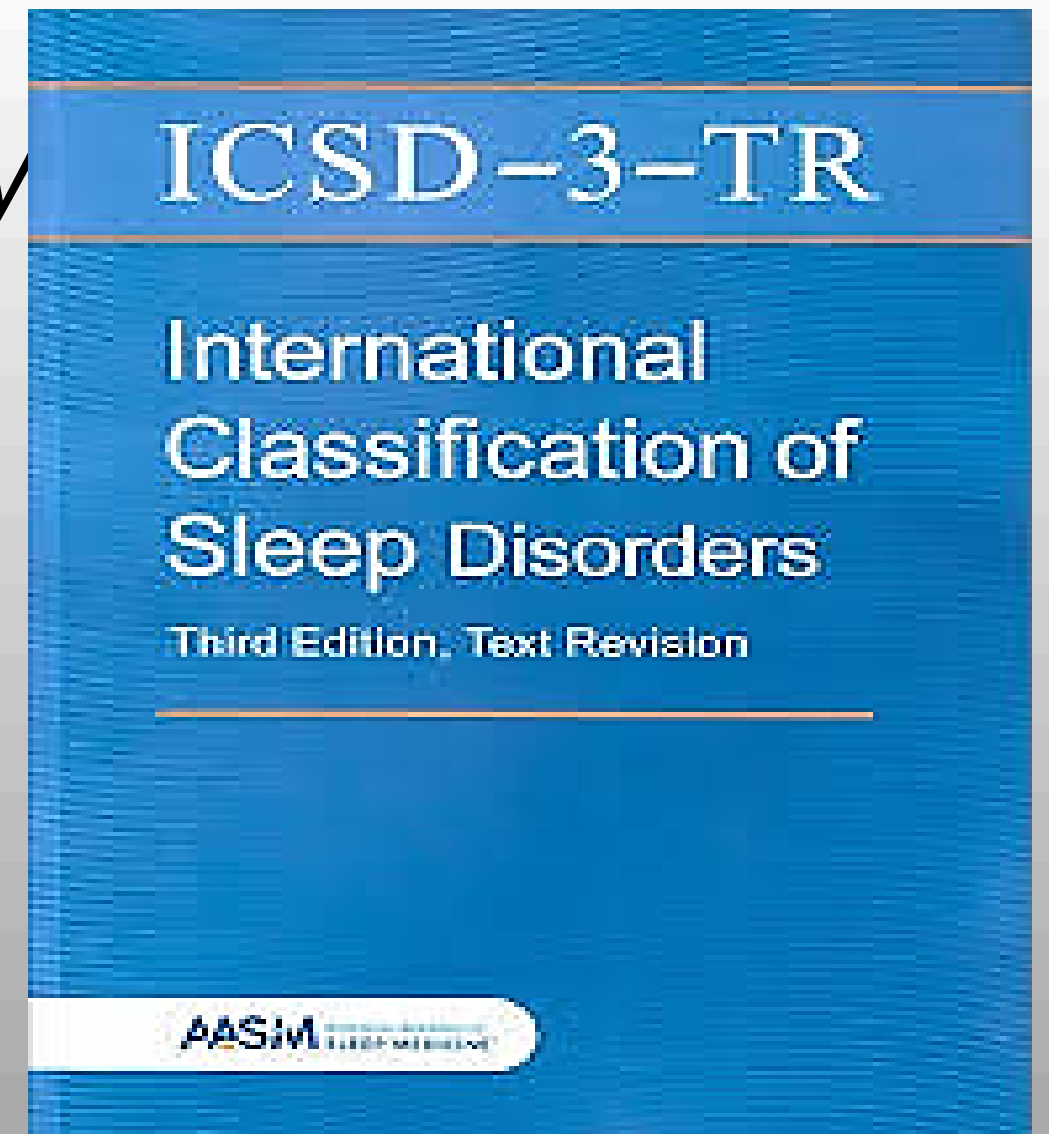
Para diagnosticar trastornos del sueño Se basa en 6 categorías principales .

- *Trastornos del Insomnio.*
- *Trastornos Centrales de la Hipersomnolencia.*
- *Trastornos Respiratorios Relacionados con el Sueño.*
- *Trastornos Centrales de la Hipersomnolencia.*
- *Trastornos del Ritmo Circadiano Sueño-Vigilia y las Parasomnias.*

La Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño-Vigilia en su 3.^a edición (ICSD-3).

Reconoce tres diagnósticos de insomnio:

- Trastorno de insomnio crónico.*
- Trastorno de insomnio a corto plazo y*
- Otros trastornos de insomnio.*



Estadísticas actuales de las organizaciones sobre el trastorno del vigilia - sueño

Datos recientes de 2025 y 2026, La OMS.

Prevalencia Global: el 40% al 50% de la población mundial.

Insomnio: Más del 30% de los adultos en todo el mundo

Datos actuales (2024-2025)

son un problema de salud pública de alto impacto en Panamá con 40%

Insomnio Frecuente: Entre el 16% y 21% de la población.

Estadísticas actuales de las organizaciones sobre el trastorno del vigilia - sueño

Panamá (CSS): ha identificado que los trastornos del sueño son comunes, graves incluyen insomnio, hipersomnias, apneas, narcolepsia y ronquidos.

Datos del Departamento de Registros y Estadísticas del (MINSA) han registrado, más de 1,000 casos anuales por insomnio no orgánico

Aumento Post-Pandemia

Los trastornos de vigilia y sueño en niños y adolescentes.

- Insomnio, parasomnias son alteraciones frecuentes que afectan hasta al 30% de esta población, causando irritabilidad, bajo rendimiento escolar y problemas de conducta.*
- En adolescentes, destaca el retraso de la fase de sueño, donde se duermen y despiertan muy tarde, alterando su ritmo circadiano.*



Causas y Consecuencias en los trastornos de sueño – vigilia de niños y adolescentes.

- **Causas:** Estrés, ansiedad, cambios en el ritmo de vida, uso de pantallas (luz azul) y factores biológicos en la pubertad.
- **Consecuencias:** Irritabilidad, problemas de aprendizaje, deterioro cognitivo, dificultades de comportamiento y problemas metabólicos (obesidad).



Famosos que presentaron el trastorno de sueño -Vigilia

- **Sigmund Freud:** *sufrió de ansiedad y problemas de insomnio crónicos, cánceres dolores afectaron la calidad de su sueño. El estudio del sueño y la vigilia en La interpretación de los sueños .*
- **Carl Jung:** *sufrió de vigilia y sueños alterados, teniendo alucinaciones al conciliar el sueño, hiperfantasía, alucinaciones auditivas, visiones y alucinaciones visuales.*



Famosos que presentaron el trastorno de sueño -Vigilia

- ***Mariah Carey:** diagnosticada trastorno bipolar tipo II en 2001, problemas de insomnio, trabajaba sin parar y no dormía seguidos por colapsos depresivos..*
- ***Shaquille O'Neal:** fue diagnosticado con apnea obstructiva del sueño (AOS) moderada le causaba ronquidos intensos y pausas respiratorias.*



Tratamiento para el Trastorno de sueño- Vigilia

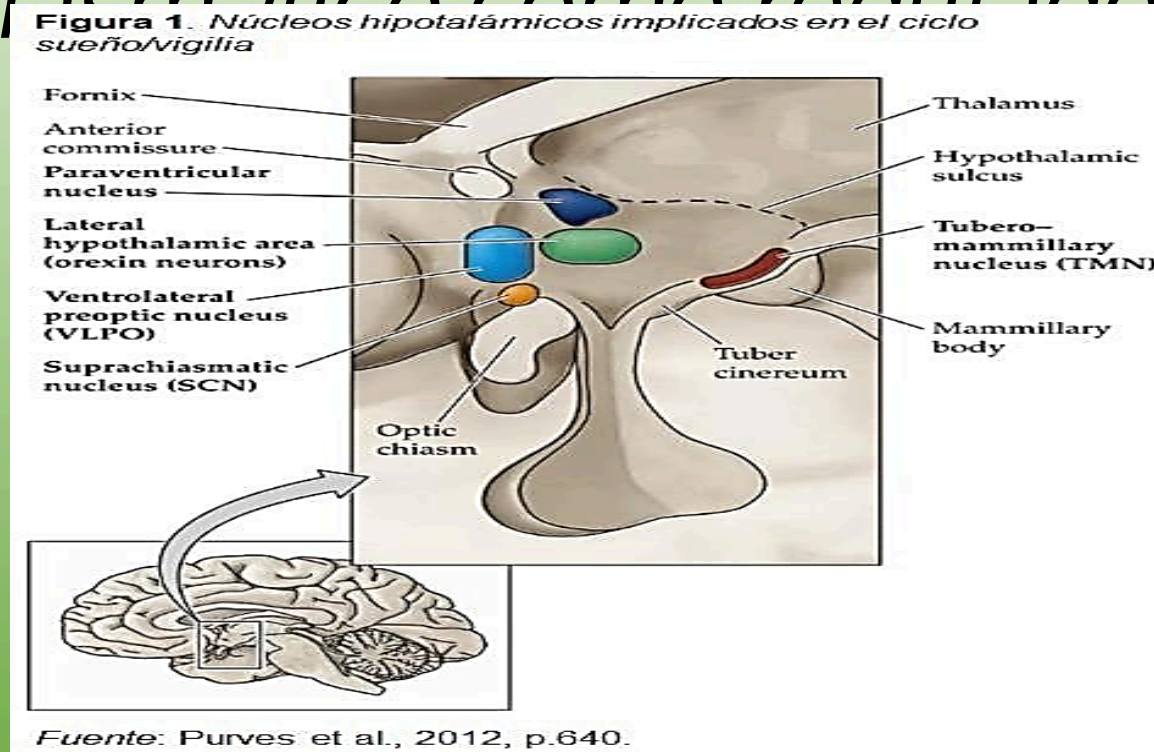
- *Se basa en reajustar el reloj biológico interno con higiene del sueño, medicamentos Agonistas de receptores de melatonina, Hipnóticos pastillas para dormir.*
- *Terapia Integrativa combina hábitos saludables junto con la terapia TCC con Técnicas para cambiar comportamientos que dificultan el sueño.*



Resumen Cronobiología del sueño y su influencia en la función cerebral.

<https://www.redalyc.org/journal/4396/439667308002/html/>

Las investigaciones sobre el proceso del sueño han considerado el estudio de diversos factores y variables, tanto ambientales como biológicas, que influyen en el desarrollo y curso de la cronobiología del sueño, entre éstas, se ha destacado la relevancia funcional del hipotálamo sobre la actividad del ciclo sueño/vigilia y particularmente del núcleo supraquiasmático como regulador de esta actividad.



Resumen Cronobiología del sueño y su influencia en la función cerebral.

<https://www.redalyc.org/journal/4396/439667308002/html/>

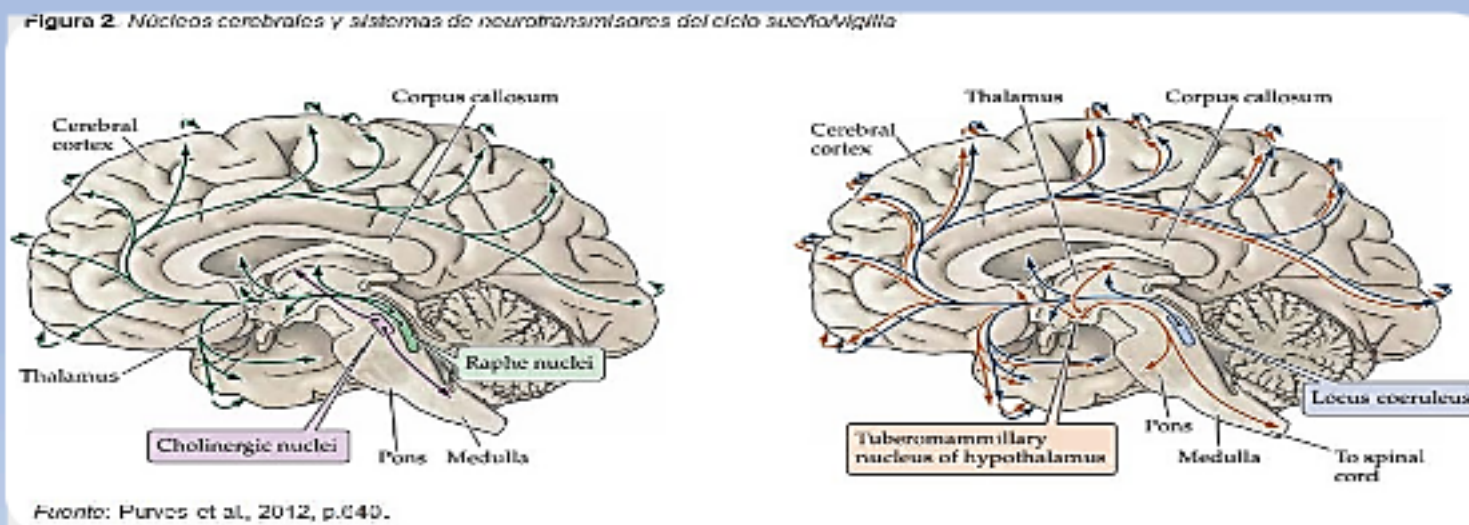
Además, se ha reconocido la importancia de neurotransmisores como la serotonina en la inducción del sueño a partir de la síntesis de melatonina, y de la acetilcolina y el GABA sobre la consolidación de la actividad cognitiva que tiene lugar durante este periodo.



Resumen Cronobiología del sueño y su influencia en la función cerebral.

<https://www.redalyc.org/journal/4396/439667308002/html/>

Así, investigaciones recientes han demostrado la relevancia del sueño sobre la función cerebral y han llegado a establecer correlaciones de las alteraciones del sueño con la clínica neuropsiquiátrica y neuropsicológica, trastornos como, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno afectivo estacional y alteraciones en aprendizaje, memoria y toma de decisiones, entre otros, presentan influencia del sueño sobre sus síntomas y disfunciones.



Recomendaciones Trastorno del vigilia - sueño

- *La OMS dormir entre 7 y 9 horas cada noche para adultos.*
- *La CSS mejorar la higiene del sueño (ambiente oscuro, silencioso, horarios regulares) y buscar ayuda médica ante un sueño no reparador persistente.*



Recomendaciones para trastornos de vigilia y sueño en niños y adolescentes.

- *Establecer una rutina de sueño constante (mismos horarios para acostarse y levantarse).*
- *Evitar pantallas al menos una hora antes de dormir, Fomentar hábitos de vida saludables y ejercicio físico, consultar a un pediatra si los problemas son recurrentes o afectan la vida del niño.*



Video trastorno de sueño-vigilia en niños



Video sobre el Insomnio



Gracias por la atención

**EL FUTURO
PERTENECE A
AQUELLOS QUE
CREEN EN LA
BELLEZA DE SUS
SUEÑOS.**

ELEANOR ROOSEVELT

LIFEDER.COM

LIFEDER.COM